日常生活活动能力情景对话图册在脑卒中后失语症患者中的应用效果

刘小金　黄欢欢　吉娜　卢秋旻
511400广州市番禺区健康管理中心(番禺区康复医院)，广东 广州

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2024.30.052

摘　要　目的：探讨日常生活活动能力(ADL)情景对话图册在脑卒中后失语症患者中的应用效果。方法：将2023年1月—2024年6月广州市番禺区健康管理中心收治的100例脑卒中后失语症患者随机分为两组，各50例。对照组实施常规语言康复训练，观察组在对照组基础上使用ADL情景对话图册进行康复训练。对比两组康复效果。结果：干预后，两组听理解、复述、命名、自发言语、失语商评分升高，且观察组高于对照组($P<0.05$)。干预后，两组日常生活交流能力检查量表、中国式功能性语言沟通能力检查法评分升高，Stroop测试结果改善，且观察组改善幅度大于对照组($P<0.05$)。干预后，两组美国国立卫生研究院卒中量表评分降低，脑卒中专用生活质量量表评分升高，且观察组改善幅度大于对照组($P<0.05$)。结论：ADL情景对话图册在脑卒中后失语症患者中的应用效果显著，能有效提高患者语言功能、日常交流能力、注意力，改善神经功能与生活质量。

关键词　脑卒中；失语症；日常生活活动能力情景对话图册
中图分类号　R743　　**文献标识码**　A

Application Effect of Activities of Daily Living Situational Dialogue Atlas in Patients with Aphasia After Stroke

Liu Xiaojin, Huang Huanhuan, Ji Na, Lu Qiumin
Guangzhou Panyu Health Management Center (Panyu District Rehabilitation Hospital), Guangzhou 511400, Guangdong Province, China

Abstract　Objective: To explore the application effect of activities of daily living (ADL) situational dialogue atlas in patients with aphasia after stroke. Methods: A total of 100 patients with aphasia after stroke who were admitted to Guangzhou Panyu Health Management Center from January 2023 to June 2024 were randomly divided into two groups, with 50 cases in each group. The control group received routine language rehabilitation training, and the observation group used ADL situational dialogue atlas for rehabilitation training. The rehabilitation effects of the two groups were compared. Results: After intervention, the scores of listening comprehension, repetition, naming, spontaneous speech and aphasia quotient in two groups increased, and the scores in observation group were higher than those in control group ($P<0.05$). After intervention, the scores of Communication Activities of Daily Living and Chinese Functional Communication Profile in the two groups increased, and the Stroop test results increased improved, and the improvement in the observation group was greater than that in the control group ($P<0.05$). After intervention, the score of National Institutes of Health Stroke Scale in the two groups decreased, and the score of Stroke-Specific Quality of Life scale in the two groups increased, and the improvement in the observation group was greater than that in the control group ($P<0.05$). Conclusion: The application effect of ADL situational dialogue atlas in patients with aphasia after stroke is remarkable, which can effectively improve language function, daily communication ability and attention of patients, and improve neurological function and quality of life.

Key words　Stroke; Aphasia; Activities of daily living situational dialogue atlas

失语症是脑卒中常见并发症之一，脑卒中患者局部脑血管出血或堵塞，导致脑血液循环障碍，若病灶包括语言功能相关大脑区域，即可引发失语症。脑卒中后失语症类型以运动性失语症和感觉性失语症为主，前者患者不能正确表达自己的意愿，后者会出现认知功能、识别功能、阅读能力下降，严重损害患者身体健康及生活质量[1-2]。常规语言康复训练能在一定程度上改善患者的语言理解能力及表达能力，但缺乏针对性，患者恢复速度慢。基于日常生活活动能力(ADL)情景对话图册的康复训练利用实物照片和抽象图片刺激患者感官，促使患者交流及表达，有助于提高语言功能恢复效果[3]。本研究旨在分析ADL情景对话图册在脑卒中后失语症患者中的应用效果。

基金项目　广州市番禺区科技计划项目(编号：2022-ZO4-070)

中国知网　https://www.cnki.net

资料与方法

将2023年1月—2024年6月广州市番禺区健康管理中心收治的100例脑卒中后失语症患者随机分为两组，各50例。两组一般资料比较，差异无统计学意义($P>0.05$)，具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核批准；患者自愿加入本研究。

纳入标准：①经头颅CT或MRI检查确诊为脑卒中；②符合《汉语失语症康复治疗专家共识》[4]中脑卒中后失语症的诊断标准；③病情稳定，意识清晰，认知功能正常；④失语症病程<1个月；⑤临床资料完整。

排除标准：①其他疾病所致失语症；②生命体征不稳定；③合并听觉、视觉障碍；④患有精神疾病。

方法：对照组实施常规语言康复训练，包括发音训练、短语训练、会话训练、文字识别等，训练5次/周。观察组在对照组基础上使用ADL情景对话图册进行康复训练。①制作ADL情景对话图册：选择150个日常生活中的常用词汇及话语，内容主要为修饰、进食、穿衣、洗澡、如厕、小便控制、大便控制、床椅转移、平地行走和上下楼梯10个主题，搭配彩色图片，制作彩色电子版话语图册，设计10个情景对话场景，内容包括ADL训练、日常家庭生活、日常病房生活等。②患者进行一对一情景对话训练，每次选择不同情景主题，引导患者对不同情景下的词汇及话语进行口语输出，30 min/次，2次/d，10次/周。训练中多鼓励患者，给予其正向反馈。③记录患者训练情况，根据其训练情况针对性制定下次训练计划。两组均干预1个月。

观察指标：①失语严重程度：采用西方失语症成套测验(WAB)评估，包括听理解(10分)、复述(10分)、命名(8分)、自发言语(10分)4项，并计算失语商(AQ)，AQ=前4项评分和×2，各项得分越高表示失语程度越轻[5]。②日常生活交流能力：采用日常生活交流能力检查量表(CADL)、中国式功能性语言沟通能力检查法(CFCP)评估，CADL总分136分，CFCP总分250分，评分越高表示日常生活交流能力越佳。③注意力：应用斯特鲁普(Stroop)测试检测，给予患者不同颜色卡片，引导其进行辨识，判断其注意力水平。注意力良好标准：正确判断≥100张卡片。④神经功能：采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评估，总分50分，得分越高表示神经功能缺损越严重。⑤生命质量：采用脑卒中专用生活质量量表(SS-QOL)评估，总分245分，得分越高表示生命质量越佳。

统计学方法：采用SPSS 25.0统计学软件分析数据；用$\bar{x}\pm s$表示计量资料，用n(%)表示计数资料，分别行t检验、χ^2检验；$P<0.05$为有统计学差异。

结　果

两组WAB评分比较：干预前，两组听理解、复述、命名、自发言语、AQ评分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)；干预后，两组听理解、复述、命名、自发言语、AQ评分升高，且观察组高于对照组($P<0.05$)。见表2。

两组日常交流能力及注意力比较：干预前，两组CADL、CFCP评分及Stroop测试结果比较，差异无统计学意义($P>0.05$)；干预后，两组CADL、CFCP评分升高，Stroop测试结果改善，且观察组改善幅度大于对照组($P<0.05$)。见表3。

表1　两组一般资料比较

组别	n	性别(n)		年龄	病程	失语症类型(n)		
		男	女	($\bar{x}\pm s$，岁)	($\bar{x}\pm s$，d)	运动性	感觉性	完全性
观察组	50	30	20	62.37±9.81	22.43±5.01	18	21	11
对照组	50	32	18	62.05±10.23	22.79±5.24	16	24	10
χ^2/t		0.170		0.160	0.351		0.365	
P		0.680		0.874	0.726		0.833	

表2　两组WAB评分比较($\bar{x}\pm s$，分)

组别	n	听理解		复述		命名		自发言语		AQ	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	50	5.04±0.78	8.02±1.01*	4.87±0.72	6.94±0.93*	4.90±0.68	6.85±0.91*	5.21±0.74	8.16±1.01*	40.04±5.97	59.94±6.51*
对照组	50	5.13±0.75	6.67±0.83*	4.91±0.69	5.56±0.84*	4.96±0.62	5.43±0.78*	5.28±0.72	6.83±0.85*	40.56±5.75	48.98±6.14*
t		0.588	7.302	0.284	7.787	0.461	8.378	0.479	7.124	0.444	8.660
P		0.558	<0.001	0.777	<0.001	0.646	<0.001	0.633	<0.001	0.658	<0.001

注：与同组干预前比较，*$P<0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

两组神经功能及生活质量比较：干预前，两组NIHSS、SS-QOL评分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)；干预后，两组NIHSS评分降低，SS-QOL评分升高，且观察组改善幅度大于对照组($P<0.05$)。见表4。

表3 两组日常交流能力及注意力比较($\bar{x}\pm s$)

组别	n	CADL评分(分)		CFCP评分(分)		Stroop测试(张)	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	50	34.75±6.92	98.26±11.47*	99.10±7.24	165.82±10.03*	98.74±10.31	137.96±12.53*
对照组	50	34.13±7.04	79.58±9.83*	98.67±7.69	133.95±8.64*	99.28±10.15	114.42±10.87*
t		0.444	8.744	0.288	17.023	0.264	10.035
P		0.658	<0.001	0.774	<0.001	0.792	<0.001

注：与同组干预前比较，*$P<0.05$。

表4 两组神经功能及生活质量比较($\bar{x}\pm s$，分)

组别	n	NIHSS评分		SS-QOL评分	
		干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	50	14.74±3.46	8.63±2.28*	121.32±21.83	174.17±23.64*
对照组	50	15.11±3.57	11.95±3.07*	120.89±22.15	148.91±22.26*
t		0.526	6.139	0.098	5.501
P		0.600	<0.001	0.922	<0.001

注：与同组干预前比较，*$P<0.05$。

讨 论

脑卒中后失语症是一种获得性语言障碍，临床研究显示，脑卒中后3个月内是失语症治疗的关键时期[6]。目前，临床多通过药物治疗、康复治疗等综合疗法治疗脑卒中后失语症，语言康复训练利用发音训练、短语训练、会话训练等刺激患者表达及交流，从而逐步恢复其语言功能[7]。但单纯语言康复训练起效慢，患者常难以坚持。ADL情景对话图册能根据患者病情特点及日常生活能力制作相关图册，针对性训练日常生活用语，帮助患者提高语言功能[8]。

本研究结果显示，干预后，观察组语言功能、日常交流能力、注意力、神经功能与生活质量均优于对照组($P<0.05$)。分析原因：①ADL情景对话图册通过生动的图片和简洁的文字为脑卒中后失语症患者提供视觉刺激，帮助其理解和表达日常生活中的各种活动，克服语言障碍，提高交流能力[9]。②图册中的图片和场景有助于患者回忆和巩固日常生活中的知识和技能，提高认知功能，通过反复观察和学习，患者可以逐渐恢复对事物的识别和记忆能力，从而改善失语症状。③使用ADL情景对话图册可以帮助患者进行针对性的语言康复训练，患者在图册指导下进行口语表达、命名、描述等训练，逐步恢复语言功能。④图册可以作为患者与家属、医护人员之间的沟通工具，提高交流效率。⑤随着语言功能的恢复，患者能够更好地进行日常生活活动，提高自理能力、生活质量。⑥ADL情景对话图册还可以作为心理治疗的辅助工具，图册中的积极场景和正面信息可以帮助患者调整心态，减轻焦虑和抑郁情绪，增强康复信心。

综上所述，ADL情景对话图册在脑卒中后失语症患者中的应用效果显著，能有效提高患者语言功能、日常交流能力、注意力，改善神经功能与生活质量。

参考文献

[1] 李志凤,白玉龙.脑卒中失语后抑郁症患者康复治疗的研究进展[J].中华物理医学与康复杂志,2019,41(4):305-308.

[2] 陈小云,李亚娟,季卫周.词汇图表与情景对话手册在脑卒中后非流畅性失语症患者中的应用[J].齐鲁护理杂志,2021,27(15):137-139.

[3] 马丽.语言图片识别卡联合主题式康复微课在缺血性脑卒中后失语症患者中的应用观察[J].黑龙江中医药,2020,49(1):57-58.

[4] 汉语失语症康复治疗专家共识组.汉语失语症康复治疗专家共识[J].中华物理医学与康复杂志,2019,41(3):161-169.

[5] 左红霞,吴红燕.以兴趣为导向的主题卡片在脑卒中后失语症患者语言康复训练中的应用效果[J].护理实践与研究,2021,18(1):54-57.

[6] 丁月琴.语言图示卡联合TTM模型在脑卒中后失语症病人全方位康复护理中的应用[J].循证护理,2024,10(2):310-315.

[7] 钟杨,李海,刘琳,等.语言训练联合益髓醒神针刺法对脑卒中后失语症患者神经功能及语言功能恢复的影响[J].中国医学创新,2023,20(19):48-51.

[8] 胡含波,何小俊,李薇薇,等.基于汉语韵律的五言绝句节奏式朗读在脑卒中后非流畅性失语症中的应用[J].中国实用神经疾病杂志,2023,26(4):416-420.

[9] 黄琴.语言图片识别卡在脑卒中失语症患者中的康复护理效果[J].实用临床护理学电子杂志,2017,2(32):14.

中国知网 https://www.cnki.net